

# 脾胃湿热证胃炎的中西医结合治疗进展

李炯闻

滨州医学院中医学院中医专业，山东滨州 264003

**【摘要】**慢性胃炎是全球范围内的常见消化系统疾病，现代西药治疗虽能在短期内有效缓解症状，然而日益增长的耐药性问题正显著地威胁着患者的长期疗效与生活质量。对慢性胃炎的辨证施治中，中医药疗法展现出显著疗效，通过实施个性化治疗策略，不仅能够有效缓解患者的临床症状，还极大地促进了其生活质量的提升与改善。文章对慢性胃炎脾胃湿热证病因以及中西医结合治疗进展进行论述。

**【关键词】**胃炎；脾胃湿热证；中西医结合治疗；综述

慢性胃炎作为消化道常见疾病，常由幽门螺杆菌感染所致，症状表现包括中上腹部饱胀、灼热感、嗳气、恶心及反酸等。针对慢性胃炎这一病症，在传统中医理论体系中虽未直接设以特定病名，但其临床症状可归类于“胃脘痛”、“纳呆”、“痞满”、“嘈杂”范畴<sup>[1-2]</sup>。鉴于抗生素耐药性的日益加剧，导致幽门螺杆菌清除率显著降低，影响了慢性胃炎症状的有效管理<sup>[3]</sup>。在此背景下，探索并实施基于中医辨证论治的个性化治疗策略，展现出在管理慢性胃炎这一复杂疾病过程中的独特优势与显著效果。

## 1 脾胃湿热证病因

### 1.1 外感六邪

朱丹溪在《格致余论》中提出的“湿热为病，十居八九”的论断，揭示了湿热病证的普遍性及其与地域环境的内在联系。从中医藏象理论分析，脾属太阴湿土，主运化水湿，其性喜燥恶湿，当湿邪困脾时，则运化失司，水湿内停，故曰“脾病多湿”；胃属阳明燥土，主受纳腐熟，其性喜润恶燥，易从阳化热，故云“胃病多燥”。现代研究也证实，湿热环境可改变胃肠道微生态平衡。同时，季节气候因素也不容忽视，长夏季节湿土当令，暑湿交蒸，更易引发或加重脾胃湿热病证。

### 1.2 饮食不节

随着社会节奏加快，饮食不规律、暴饮暴食成为普遍现象，正如《素问·痹论篇》所言“饮食自倍，肠胃乃伤”，《素问·生气通天论篇》“阴之五宫，伤在五味”的论断，在当代表现为辛辣刺激、肥甘厚味和酗酒等不良饮食习惯。这些饮食因素共同作用，导致脾胃运化功能障碍，水谷精微不能正常输布，反而酿生湿浊，临床数据显示长期饮食不节者出现舌苔厚腻的比例较高。湿浊郁久化热，形成湿热蕴结中焦的病理状态，表现为胃脘灼热、口苦黏腻等典型症状<sup>[4-5]</sup>。现代代谢组学研究证实，此类患者血清中乳酸、丙酮酸等代谢产物水平异常升高，与中医“湿热困脾”的理论高度吻合，这种由饮食失宜到脾胃损伤再到湿热内生的渐进过程，正是当代脾胃湿热证高发的关键病机。

### 1.3 其他因素

脾胃湿热证的形成与体质因素及情志失调密切相关。年老体衰或素体脾虚者，脾胃阳气本已不足，运化水湿能力减弱，此时若外感湿热邪气，则如薛生白所言形成“太阴内伤，湿饮停聚，客邪再至”的病理格局，临床观察发现此类患者血清 IL-6 等炎症因子水平较常人升高。情志因素在发病中同样关键，现代医学证实慢性应激可使胃黏膜血流量减少，这与中医“思虑伤脾”导致脾气不升、“郁怒伤肝”引发肝气犯胃的理论相契合。脾虚湿盛者更易受情志刺激，而长期情志不畅又进一步损伤脾胃功能，最终导致湿热难解的复杂病机。

## 2 慢性胃炎脾胃湿热证的中西医结合治疗

近年来，随着我国医疗水平的不断提高及中医研究的不断深入，中西医结合治疗逐渐被应用到慢性胃炎的临床治疗中，且大多取得了较为理想的治疗效果<sup>[6]</sup>。对于慢性胃炎患者而

言,中西医结合治疗,不仅可以发挥西医治疗的优势,有效减少其胃酸分泌,修复和完善其破损的胃黏膜和腺体,调节其机体的新陈代谢,还可以发挥中医治疗的优势,在一定程度上减少抗生素的使用,降低不良反应的发生风险,改善胃黏膜病变,提高整体的治疗效果,改善预后<sup>[7]</sup>。

在赵雪香等的研究中<sup>[8]</sup>,对幽门螺杆菌感染所致慢性胃炎脾胃湿热证患者,采用四联西医疗法的基础上增加中药连朴饮加减治疗。研究结果显示,观察组治疗方案,在改善上腹胀满、口干、食欲减退的中医证候积分方面,作用显著。观察组上腹胀满、上腹疼痛、口干症状缓解时间分别为 $(2.14 \pm 1.15)$  d、 $(2.73 \pm 1.32)$  d、 $(4.32 \pm 1.53)$  d,均显著低于常规药物治疗的对照组。观察组幽门螺杆菌根除率为98.92%,高于对照组的92.47%。复发率为3.26%,低于对照组的13.95%。此外,经2周治疗观察组各项生活质量评分均高于对照组。在四联西医疗法基础上联合中药连朴饮治疗脾胃湿热型胃炎,能够通过中西医协同作用实现标本兼治的综合疗效。四联疗法可抑制胃酸分泌并直接作用于幽门螺杆菌,实现基础性的治疗目标;连朴饮则通过多维作用机制,显著增强整体治疗效果。方中黄连、厚朴及其同类药物不仅展现出协同抗菌的作用机制,还能够显著抑制胃黏膜的炎症反应过程,通过调节促炎细胞因子的生成与释放水平,从而发挥其抗炎功效。半夏、基于传统医学理论,栀子及其同属成分能够显著增强胃肠动力,对于脾胃湿热所导致的经典脘腹胀满病症,展现出卓越的改善效果。石菖蒲、芦根及其同类草药的作用机制在于调节机体的水分与液体代谢平衡,旨在消除因湿气积聚导致的病理状态,从而有效缓解由湿浊停滞引发的病症。采用中西医结合策略的治疗方法在临床实践中展现出以下优势:能够加速患者的临床症状缓解,并有效缩短疾病进程;通过维护胃黏膜屏障完整性来减少西药可能引发的副作用;全面调理脾胃机能,进而优化中医辨证施治的疗效指标,实现综合性的健康改善。既直接对抗致病微生物,又通过调整机体状态实现全面康复,既解决症状,又根治病因,显著提升治愈效率,有效减少复发风险,达成综合性的治疗目标。

石喜龙等在研究中<sup>[9]</sup>,分析了脾胃湿热型慢性浅表性胃炎患者采用半夏泻心汤加减的实际治疗效果。研究组脾胃湿热型慢性浅表性胃炎患者,在西医常规治疗基础上应用半夏泻心汤加减治疗。结果显示,研究组治疗总有效率为97.56%,对比对照组80.49%显著较高。治疗后,研究组胃痛、嗳气、纳差、痞满的中医证候积分分别是 $(4.03 \pm 0.47)$ 分、 $(3.54 \pm 0.38)$ 分、 $(3.02 \pm 0.37)$ 分、 $(3.67 \pm 0.37)$ 分,均低于同期对照组。胃肠症状评定量表(GSRS)评分方面,治疗10d时观察组评分是 $(7.01 \pm 1.25)$ 分,低于同期对照组 $(12.38 \pm 1.44)$ 分。此外,观察组治疗方案在改善患者炎症因子指标方面也具有显著优势。常规西药治疗联合半夏泻心汤加减治疗脾胃湿热型胃炎,通过中西医协同作用形成多层次的治疗效应。西药治疗主要针对胃酸分泌和幽门螺杆菌进行直接干预,而半夏泻心汤则从中医整体观出发,发挥双向调节作用。方中半夏、干姜以其辛开苦降之性,能够有效和胃降逆,而黄芩与黄连则凭借其清热燥湿的功效,共同作用于消化系统的调节。人参、大枣及甘草的组合,则侧重于健脾益气,三者相辅相成,构建了一种寒热并举、补泻兼顾的药物配伍策略,可中和过强的胃酸分泌,还可优化胃肠的动力平衡,全方位地促进消化系统的健康与稳定。中西医结合治疗不仅在抑制胃酸分泌与优化胃肠蠕动功能之间实现了协同作用,同时还能有效杀灭病原体并促进受损黏膜屏障的修复,通过调控炎症反应与免疫平衡机制,全方位地改善胃肠道健康状况。临床观察揭示,通过整合运用半夏泻心汤,患者的消化系统症状,特别是胃痛与腹胀,展现出更为迅速的缓解趋势。同时,伴随口苦、口黏以及舌苔呈现黄腻特征的湿热证候亦显著得以改善。这一综合干预措施的结果是,整体治疗的有效率呈现出明显的提升态势。其功效特征显著,不仅能够根除病因,还通过恢复脾胃系统正常的升清降浊机能,实现了标本兼治的目的,有效预防了症状的复发,确保了治疗效果的持久稳定,这充分彰显了中西医整合治疗策略的独特优势与价值。

张瑞等在研究中<sup>[10]</sup>,分析了黄连温胆汤加减治疗慢性胃炎伴胆汁反流脾胃湿热证的临床疗效。对照组给予铝碳酸镁咀嚼片,观察组给予黄连温胆汤加减口服。结果显示,观察组治疗总有效率 94.74%,对比对照组 82.05%显著较高。治疗后,两组中医各症状评分及证候总评分降低。治疗 4 周时,观察组各项评分均低于同期对照组。治疗 4 周,观察组肿瘤坏死因子- $\alpha$  (TNF- $\alpha$ )、白细胞介素-8 (IL-8)、前列腺素 E<sub>2</sub> (PGE<sub>2</sub>) 和表皮生长因子 (EGF) 水平分别为 (11.68 $\pm$ 4.04) pg/ml、(11.55 $\pm$ 2.26) pg/ml、(87.92 $\pm$ 6.55) pg/ml、(53.47 $\pm$ 5.24) pg/ml,其中 TNF- $\alpha$ 、IL-8 含量低于对照组,PGE<sub>2</sub>、EGF 含量高于对照组。治疗 6 个月后随访,观察组复发率为 8.33%,对比对照组 12.50%显著较低。两组患者在治疗期间均未发生不良反应及毒副作用。黄连温胆汤加减治疗慢性胃炎伴胆汁反流脾胃湿热证临床疗效显著,其作用机制可能与调节血清 TNF- $\alpha$ 、IL-8、PGE<sub>2</sub>、EGF 表达水平有关。黄连温胆汤加减治疗慢性胃炎伴胆汁反流脾胃湿热证的显著疗效,源于其独特的多靶点调节作用,能够精准调控炎症修复网络,从而实现对病变的综合干预与改善。该方剂以黄连清热燥湿、基于温胆汤的传统功效,其主要作用在于调理胆气与胃气,通过促进内脏功能的协调,实现对关键炎症因子与修复因子之间动态平衡的优化调控。具体而言,在本研究设计中,我们着重分析了黄连中的生物碱成分对抑制促炎因子 TNF- $\alpha$  与 IL-8 过量分泌的作用机制,以及如何有效减轻胃黏膜炎症反应。此外,陈皮及半夏等草药的活性成分被发现能够促进胆汁的排出,从而改善胃食道反流现象。更重要的是,我们揭示了该方剂通过上调胃黏膜保护因子如 PGE<sub>2</sub> 和 EGF 表达水平,加速胃黏膜的修复过程。这一双向调控机制不仅有效地遏制了炎症级联反应的进展,同时显著强化了黏膜屏障功能,建立起一个“抑制炎症-保护黏膜-促进修复”的良性循环过程。临床观察显示,患者在采用特定治疗方案后,胃脘灼痛与口苦等症状显著减轻,且通过胃镜检查证实,胃黏膜炎症得以缓解,胆汁反流现象亦有所改善。这一系列积极变化的根本原因,在于有效恢复了胃内微生态的稳态平衡,充分彰显了中医学强调整体调治、平衡阴阳的独特优势与治疗策略。

### 3 小结

西医治疗慢性胃炎,具有用药便捷、作用迅速的优势。然而也面临着治疗周期冗长、复发风险高及副作用频发的挑战。中医治疗通过辨证施治的方法,能够减轻长期使用西药可能引发的机体损害,还能精准地调适患者的体质状态,有效缓和其临床表现。但亦存在治疗机理解析不足、理论体系内部分歧、以及治疗实践标准不一的局限性。在综合医学实践中,针对幽门螺杆菌感染的治疗策略通常涉及中西医结合的方法,具体包括将传统中药与现代抗生素协同应用于病患治疗,注重通过调和脾胃功能和清除湿热症状来改善患者的整体健康状态,以此促进疾病的康复和预防复发<sup>[11]</sup>。中医药治疗策略,通过清热燥湿、健脾和胃以及调理气血等传统疗法,改善患者的临床症状与体质状况,缓解由胃部炎症及幽门螺杆菌感染引发的不适感,展现出其在消化系统疾病治疗中的独特优势与潜力。中西医结合的整合性治疗策略,能够显著提升临床疗效,同时有效降低药物相关副作用,并有助于防范疾病复发的风险,实现更为全面和优化的健康管理目标。展望未来,在针对慢性胃炎脾胃湿热证的治疗,中西医结合研究需针对理论整合难度、临床疗效评估标准统一性问题、多学科合作机制的优化等挑战,不断深化对中药在抑制幽门螺杆菌方面作用机理的研究,以及探索其与西医药物协同治疗的可能性,对于开发出更为高效且综合性的治疗策略,显著提升患者的临床疗效,改善其整体生活质量。

### 参考文献

- [1]刘方红,王栋.中西医结合治疗幽门螺杆菌相关性胃炎临床观察[J].山西中医,2024,40(1):13-14,18.
- [2]杨兴,王益俊,卢锦华,等.中西医结合治疗慢性非萎缩性胃炎合并 Hp 阳性临床观察[J].光明中医,2023,38(20):4015-4017.

- [3]吴芳,李龔,杨舒淳.中西医结合治疗幽门螺杆菌胃炎 80 例临床疗效观察[J].中医临床研究,2022,14(30):112-114.
- [4]肖灵辉,骆俊.幽门螺杆菌相关性胃炎中西医结合治疗的临床疗效观察[J].内蒙古中医药,2023,42(2):1-3.
- [5]李莉.中西医结合治疗慢性萎缩性胃炎临床疗效分析[J].世界复合医学,2021,7(5):63-65.
- [6]张亚姝.中西医结合治疗老年慢性萎缩性胃炎的临床效果及安全性分析[J].亚太传统医药,2021,17(12):117-119.
- [7]刘玉青,王宝军.探讨中西医结合治疗慢性浅表性胃炎的临床疗效[J].中国社区医师,2020,36(4):129-130.
- [8]赵雪香,李春光,章妍,等.连朴饮加减联合四联疗法治疗脾胃湿热型幽门螺杆菌感染的疗效观察[J].实用中医内科杂志,2025,39(5):30-33.
- [9]石喜龙,宋晓磊.半夏泻心汤加减治疗脾胃湿热型慢性浅表性胃炎的临床效果分析[J].临床研究,2025,33(2):126-129.
- [10]张瑞,苏坤涵,刘万里.黄连温胆汤加减治疗慢性胃炎伴胆汁反流脾胃湿热证的临床疗效及其对  $\text{TNF-}\alpha$ 、IL-8、PGE2、EGF 的影响[J].中医药信息,2025,42(6):41-46.
- [11]杜娜,朱辰辰,尚青青,等.藿朴夏苓汤联合四联疗法治疗慢性胃炎湿热中阻证患者的效果[J].中国民康医学,2025,37(5):118-121.